



1

56. ÅRGANG | 01 • 2019

ARTIKEL

PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK TIDSSKRIFT
FORLAGET SKOLEPSYKOLOGI • PÆDAGOGISKE PSYKOLOGERS FORENING

Indhold

Skal man spørge børnene?

Den sundhedsfremmende betydning af et tilbud om "vandgymnastik" for sårbare gravide og babysvømning for sårbare mødre

PP-tjenesten: Individ, system eller individ i systemet?

Ligeværdigt samarbejde med børn, forældre og professionelle – inspiration fra Åben Dialog

Vores seksualitet udvikles gradvist gennem det liv vi lever – også i barndommen

Fælleskabende idræt for mennesker med autismspektrumforstyrrelse

Rasch Methods for Beginners

Det professionelle samarbejde ingen kunne finde – men alle søgte

Den sundhedsfremmende betydning af et tilbud om "vandgymnastik" for sårbare gravide og babysvømning for sårbare mødre



Denne artikel belyser, at det i samarbejde med relations- og fagligt kompetente frivillige kan lykkes professionelle at tilrettelægge babysvømning på en sådan måde, at sårbare mødre oplever at mestre både at være og at kunne. De positive handleerfaringer giver indsigter og viden, som kan øge mødrenes kompetence til fremadrettet at kunne handle sig både til egen og barnets sundhed.

Af Lise Hostrup Sønnichsen, lektor, Videncenter for Sundhedsfremme og Videncenter KOSMOS, UC SYD

I dag er det almen børnesagkyndig viden, at de første 1.000 dage af et barns liv har stor betydning for udviklingen af livsduelighed, og at kvaliteten af tilknytningen mellem barn og omsorgsgiver er en nøgle til denne udvikling. Forskningsbaseret viden om tidlige indsatser i sårbare familier er betydningsfuld, da det er veldokumenteret, at en tidlig indsats har betydning, hvis chanceulighed skal mindskes i forhold til uddannelse og sundhed (Heckman 2006; Heckman et al. 2015; Diderichsen 2011; Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse 2014; Sundhedsstyrelsen 2016, 2017a; Jørgensen and Preisler 2016; *FORSK2015* 2017).

Nærværende artikel beskriver et kvalitativt studie af et projekt ved navn *Aqua Vitae* med fokus på babysvømning for sårbare mødre og vandaktivitet for sårbare gravide skabt af sundhedsplejen i en mellemstor kommune i Syddanmark i samarbejde med frivillige fra *Red Barnet*.

Målgruppe

Efter anvisning fra regionen inddeler sundhedsplejen gravide og mødre i fire kategorier for at kunne målrette tilbud (Region Syddanmark 2014): Grøn gruppe er et basis tilbud. Gul gruppe er et udvidet basistilbud, som eksempelvis omfatter rygere. Orange gruppe er et udvidet tilbud, som typisk relaterer sig til en tværfaglig indsats omkring gravide med mere komplekse problemstillinger. Rød gruppe omfatter kvinder, som har behov for et specialiseret tilbud eksempelvis kvinder med misbrug, psykiatriske diagnoser m.v. I alt har 21 kvinder fra den orange og røde gruppe deltaget i *Projekt Aqua Vitae*.

Case orange gruppe

Britta er alenemor til tre. Hun har en mellemlang uddannelse, men er sygemeldt fra sit arbejde pga. en depression. Hun er overvægtig og

plaget af ledsmerter og kommer ikke meget ud. I 22. uge blev hun af sin jordemor henvist til vandaktivitet, og hun deltager nu i babysvømning med sin datter.

Case rød gruppe

Nanna har haft en omtumlet barndom og fik som teenager en psykiatrisk diagnose. Som nybagt mor blev hun indskrevet på en specialiseret familieinstitution i et par måneder. Hun bor nu i egen lejlighed og får støtte af en familiekonsulent. Hun går til babysvømning med sin søn.

Rammer og mål for Projekt Aqua Vitae
Aktiviteterne foregik i en svømmehal med et almindeligt bassin, et varmtvandsbassin og et babybassin. Forløbet blev ledet af en specialpædagog med en instruktøruddannelse i babysvømning. Sammen med hende var en frivillig og en sundhedsplejerske i vandet. De i alt 13 frivillige fik et introduktionskursus, og deres opgave var at stå til rådighed for mødrene i omklædning og i vandet.

Et kvalitativt forskningsdesign

Artiklens formidlede erkendelser er resultatet af en fortolkning af de frivilliges, mødrenes og de professionelles oplevelse af meningsfulde fænomener (Gadamer 2007; Zahavi 2014; Brinkmann and Tanggaard 2015) i relation til følgende forskningsspørgsmål:

Hvordan kan vandaktivitet for gravide og babysvømning for sårbare mødre bidrage til opbygning af mestring i rollen som mor og kompetence til at kunne

*handle sig til sin egen og sit barns sundhed*¹. Analysen har haft karakter af en cirkulær analytisk proces med bevægelse frem og tilbage mellem fortolkningen af enkeltdele og en forståelse af helheden og mellem et empiristyrethet og et teoristyrethet fokus (Gadamer 2007; Gleerup 2004).

Forskningsaktiviteter

Med baggrund i mødrenes sociale sårbarhed blev gruppeinterviewet valgt som primær metode. Alle mødre, som mere end én gang havde deltaget i projektet, blev kontaktet og spurgt, om de ville aflægge interview i sundhedsplejens hus. Målgruppen kan jf. sundhedsplejen være svær at lave aftaler med og flere afviste interview med travlhed, mens andre aldrig svarede. Ud af 21 adspurgte gav ni tilsagn, men på dagen kom kun fem og tre af dem senere end aftalt. De udeblevne blev kontaktet via SMS, hvorefter der blev indgået en aftale om gennemførelse af telefoninterview. Gruppeinterviewene blev således splittet op i tre gruppeinterview og syv enkeltinterviews, hvoraf fire var over telefonen. De interviewede mødre fordeler sig i forhold til Sundhedsplejens kategorisering med fem fra den røde kategori og fire fra den orange kategori. De fem professionelle i projektet blev interviewet sammen og ligeså fem af de frivillige. Interviewene blev gennemført i semistruktureret form og afsluttet med en opsummering af pointer, som informanterne herefter kunne bekræfte, afkræfte eller uddybe

1 I resten af artiklen benævnes det at kunne handle sig til egen og barnets sundhed – *sundhedshandlekompetence*?

(Brinkmann and Tanggaard 2015; Kvale 1997).

Informanternes indbyrdes dialog i gruppeinterviewene bidrog til eksplicitering af viden af mere "tavs" karakter, hvilket fjede dybde til besvarelsene. Tre af telefoninterviewene føltes derimod negativt præget af indskrænkede muligheder for kropslig aflæsning. Dybden i mødrenes besvarelse synes at afhænge af mulighederne for, som interviewer at kunne levere et åbent, sanseligt og intuitivt nærvær, som både var rettet udad mod kvindernes kommunikation i form af fx ord, gestik, mimik, men samtidig indad mod oplevelsen af, hvordan verbale som nonverbale signaler kunne tolkes (Brinkmann og Tanggaard 2015).

Eksisterende forskningslitteratur

Der er søgt systematisk i databaserne; Social Care online, PubMed og ERIC. Inklusionskriterier var forskningsartikler publiceret efter 2007 på et nordisk sprog eller engelsk. Der er ikke fundet forskningslitteratur om baby-svømning eller vandaktivitet i relation til målgruppen. Derimod er der fundet en evaluering af andre typer af indsatser for sårbare gravide, som viser betydningen af en anerkendende tilgang (Sundhedsstyrelsen 2017a) og flere artikler om graviditet og sundhed. Svømning er en anbefalet og meget benyttet motionsform blandt gravide i Danmark (Juhl et al. 2012; Sundhedsstyrelsen 2017b) med positiv betydning for humør, søvn og fysisk sundhed (Backhausen et al. 2014).

En holistisk og sundhedspædagogisk tilgang

Teoretisk tages der i artiklen udgangspunktet i en bred og positiv forståelse af sundhed samt betydningen af en sundhedspædagogisk og holistisk tilgang til fremme af sundhed. Derudover har de beslægtede begreber *mestring* og *self-efficacy* en central plads.

Med et positivt syn på sundhed menes, at ikke bare fravær af sygdom, men også oplevelsen af livskvalitet og velvære anses for at have betydning for sundhed. Et bredt sundhedsbegreb henviser til, at både livsstil og levevilkår har indflydelse på sundhed (Jensen and Johnsen 2010; Jensen 2009). En gravid kvindes livsstilsvaner kan forstås som et levevilkår for et foster på samme måde, som børn er underlagt forældres livsstil som et levevilkår. Med udgangspunkt i eksisterende forskningslitteratur belyses forskellige leve- og livstilsfaktorer, som karakteriserer målgruppens sundhed i det følgende afsnit. Der kobles til projektet gennem citater fra interviewene.

Målgruppen i relation til livsstil under graviditeten og brug af sundhedsydelser

En stor andel af mødrene i *Projektet Aqua Vitae* har ingen eller en lav uddannelse, hvorfor de, sammenlignet med højere uddannede kvinder, har lavere sandsynlighed for at imødekomme anbefalingerne fra Sundhedsstyrelsen for sundhedsadfærd under graviditeten, bl.a. hvad angår motion (Broberg et al. 2015). Motion nedsætter risikoen for komplikationer i graviditeten (Broberg et al. 2015), mens fx højt BMI og følelsesmæssige forstyrrelser forøger risikoen (Andersen et al. 2015). Proble-

mer relateret til fysisk sundhed præger også projektets målgruppe efter fødslen: A: *“Mange er overvægtige, har dårlige knæ og bruger ikke deres krop ret meget. “De har faktisk svært ved at komme ned på gulvet til deres børn (...).”* B: *“Om det er fysiske skavanker, fordi de ikke synes, det er i orden at have psykiske skavanker, det ved jeg ikke, nogen gange er jeg lidt i tvivl om, hvad der er hvad (...)* A: *“Der er eksempelvis rigtig mange, der har – bækkenløsning.”* (interview med professionelle).

Udsatte kvinder bruger sundhedstilbud under og efter graviditeten mindre, hvilket kan skyldes en almen mistillid til systemet og/eller en manglende tro på eget værd i omgang med andre (Sundhedsstyrelsen, 2017a), hvilket genspejles i *Aqua vitae*: *“Jeg kan faktisk ikke komme i tanke om en eneste, hvor det har været en succes med almindelig mødre-gruppe.”* (interview af professionelle).

Målgruppen i relation til sociale relationer og fællesskab

Når det kommer til sociale relationer, er mødrenes sårbarhed særlig udtalt. Mange er alene-forældre og har fået barn før vennerne og står i perioder uden for arbejds- og uddannelsesfællesskaber. Flere mangler familiær stabilitet og står uden rollemodeller blandt deres nære i forhold til sundhedshandlekompetence.

Jf. forskningen optræder risikofaktorer i relation til sundhed ofte i mønstre, dvs. at flere er tilstede samtidig. En enkelt risikofaktor, som eksempelvis overvægt, vil kunne forværre den samlede sundhedstilstand mere, end

hvis den havde stået alene på baggrund af en samlet stor sårbarhed. På samme måde har det større effekt, når det lykkes at reducere bare én risikofaktor, når sårbarheden er stor (Diderichsen, 2011). Et fokus der genspejles i *Projektet Aqua Vitae*: *“Jeg er ikke så naiv, at jeg tænker, at 20 års lavt selvværd og dårlig kropsopfattelse kan ændres ved vandaktivitet. Men det kan være et led i en positiv udvikling!”* (interview af professionelle).

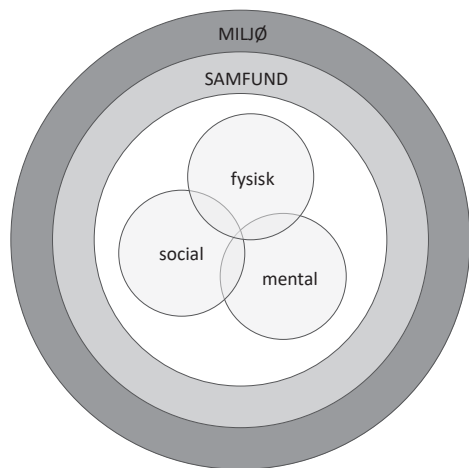
En holistisk og sundhedspædagogisk tilgang til fremme af sundhed

I en holistiske tilgang forstås fysiske, sociale og mentale² sundhedstilstande som tæt forbundne. Social sundhed handler overordnet om at føle sig som en del af et fællesskab og om at kunne udvikle sig i fællesskabet. Fysisk sundhed relaterer sig bl.a. til oplevelsen af fysisk velbefindende. Mental sundhed er relateret til en oplevelse af at trives og kunne udfolde sine evner og håndtere de udfordringer, som dagligdagen byder og samtidig yde et bidrag til fællesskabet (Thybo 2016; Holstein 2011; Jensen 2009).

Som model 1 viser, griber sociale, mentale og fysiske tilstande ind i hinanden, så eksempelvis en forbedring eller en forværring af den fysiske tilstand vil kunne påvirke både den sociale og mentale sundhedstilstand. De ydre ringe i modellen viser, hvordan det ydre miljø også har indflydelse.

² Psykisk sundhed er ikke synonymt med psykisk sundhed, men berøres kun indirekte gennem et fokus på mental sundhed.

Model 1



Model over det holistiske sundhedsbegreb efter Schulz og Pedersen (Schulz et al., 2010)

Mestring

Et nøglebegreb i denne artikel er begrebet mestring, beslægtet med begreber som empowerment, resiliens og self-efficacy. Jeg har her valgt at tage udgangspunkt i en model for mestringvilkår udviklet for år tilbage af Hilchen Sommerschild (Gjærum, Grøholt, and Sommerschild 2007) samt Albert Banduras forskning i opbygning af self-efficacy (Bandura 1990, 1997). Sommerschilds model er udviklet med baggrund i litteratur om resiliens og tilknytning, eksempelvis Caplan (1989), Lazarus (1966), Rutter (1970), Antonovsky (2004) Bowlby (1982) Fonagy (1994) m.fl. Den deler sig i to spor – et tilknytningsspor og et kompetencespor, som begge har stor betydning for et menneskes selvbillede og den modstandskraft, der skal til for at kunne klare de udfordringer, som livet bringer. Punkterne i hvert spor udgør

forudsætninger for opbygning af henholdsvis sunde tilknytningsstrategier og kompetencer. Med andre ord et “spor”, der handler om følelsen af at *være noget for nogen og kunne modtage og give kærlighed* og så et “spor”, der handler om oplevelsen af *at kunne noget* og *at være til gavn* (Gjærum, Grøholt, and Sommerschild 2007).

Self-efficacy

Banduras begreb *self-efficacy* (Bandura 1990, 1997) relaterer sig til det at have troen på egen succes i udførelse af handling. Den kan opbygges på fire måder og gerne i kombination; 1: Gennem succesoplevelser i udfordrende aktiviteter. 2: Gennem vikarierende erfaringer, så som at opleve, hvordan andre overvinder problemer. 3: Gennem andres overtalelse og opmuntring og andres hjælp til at tilpasse sværhedsgraden i udførelsen af opgaver. 4: Ved at styrke egen fysik og træning i at tænke positivt og gennem reduktion af negativt stress (Bandura 1990, 1997).

Sundhedspædagogik

Et fokus på mestring og self-efficacy er i tråd med en sundhedspædagogisk tilgang til opøvelse af sundhedshandlekompetence. Sundhedspædagogik er mulighedstænkning, og dens mål er at skabe engagement, viden og indsigt. Målgruppens medbestemmelse og egne meningsfulde aktive handlinger er i fokus, hvilket betyder, at den professionelle rolle bør være centreret om at støtte og vejlede ud fra målgruppens perspektiv. At kunne handle sig frem mod egen sundhed kræver blandt andet, at man kan forholde sig kritisk til egne vaner, har viden om sundhedseff-



Model 2

(ud fra Gjørum, Grøholt, and Sommerschild 2007, 67)

fekter og ved noget om alternative sundhedsfremmende måder at handle på. Positive handleerfaringer med sundhedsfremmende aktivitet er betydningsfulde (Jensen 2009; Jensen and Johnsen 2010).

Tilknytning

De tilbagemeldinger, som et barn får fra sine omsorgsgivere på forskellige livsudspil, har betydning for, om en kropsligt sanset og indre forankret tryghed kan opstå. Her spiller mødre-nes egne erfaringer med følelsesmæssig tilgængelighed i barndommen ind. Kvalitet i tilknytning er bestemmende for, hvilke forestillinger barnet udvikler om sig selv og andre mennesker. Derfor overføres indre modeller for samspil ofte i generationer (Bowlby 2008). Stærke øjeblikke af oplevelse af samhørighed mellem omsorgsgiver og barn – *stjernestunder* – er betydningsfulde for opbygning af kvalitet i tilknytning (Stern 2012; 2007). Den posi-

tive berøring af kroppens største sanseorgan, huden, samt øjenkontakten, mimikken og stemmeføringen har betydning for den kommunikation, der skaber tilknytning (Stern 2012 2007; Hart 2016; Brodén 2010).

Resultater af undersøgelsen De af-professionaliserede professionelle

Det er indledningsvist betydningsfuldt at påpege, at andre, som skulle få mulighed for at skabe et lignende projekt, skal tage højde for det store *know how*, som de frivillige i dette projekt har været i besiddelse af. Der er gennemgående tale om kvinder med en høj relationskompetence og faglighed, som er opbygget gennem et langt arbejdsliv – typisk pensionerede special-pædagoger, sundhedsplejersker etc.: *“folk, der kender grænsen for, hvor man skal hjælpe, og hvor man skal vente”* (interview af de professionelle).

De frivillige har evnet at arbejde sundhedspædagogisk, og deres mulighed for at af-professionalisere sig selv i rollen som frivillig har haft betydning for, at de har kunnet skabe den tillid, der har givet mødrene mod på at åbne sig. De har med andre ord haft fordel af faglige kundskaber uden samtidig at skulle repræsentere systemet og varetage det professionelle ansvar, fordi dette ansvar har ligget hos sundhedsplejen.

Det særlige ved babysvømning

Undersøgelsen bekræfter i relation til de sårbare gravide blot de resultater, som andre og større undersøgelser allerede har vist, nemlig at motion i vand har flere positive effekter på kvindens sundhed (Andersen et al. 2015; Broberg et al. 2015; Juhl et al. 2012). Den bekræfter også, at en anerkendende tilgang har betydning for at opnå succes i arbejdet med sårbare mødre (Sundhedsstyrelsen 2017a). Det er således særligt i relation til brugen af babysvømning, som middel til at arbejde med sårbare mødres mestringsevne og sundhedshandlekompetence, at undersøgelsen har ny viden at tilbyde.

Informantgrupperne bruger forskellige ord, men analysen viser, at de er meget enige om, hvilke fænomener, der er særlig betydningsfulde i brugen af babysvømning. Der er særligt fem pointer, som er værd at belyse:

- Babysvømning giver mod til at overvinde egne grænser for barnets skyld
- Babysvømning tilbyder en særlig ramme for opbygning af kvalitet i tilknytning

- Babysvømning tilbyder et rum, som muliggør positive erfaringer af egen krop i bevægelse
- Babysvømning kan danne baggrund for dannelsen af en alternativ mødregruppe
- Babysvømning tilbyder en naturlig kontekst til opbygning af praktiske kompetencer af betydning for mestring af rollen som mor

At overvinde egne grænser for barnets skyld

Det har været opbyggeligt for mødrenes oplevelse af at mestre rollen som mor, at de har været i stand til at overvinde egne grænser i ønsket om at gøre noget særligt for deres børn. Af forskellige årsager har de alle i begyndelsen oplevet deltagelsen i babysvømning som grænseoverskridende, enten pga. angst for at komme ud blandt andre, manglende tro på, at de kunne håndtere barnet eller utilpashed over at skulle vise sig nogen foran andre. Deres deltagelse har været betinget af, at holdet var lukket, gratis og tilbød støtte. I nedenstående citat beskriver to af de professionelle en mors kamp med sig selv: A: *“Der var særligt en mor, som prøvede at stikke af fra det, men så gjorde hun det for barnets skyld. Det der med at blive, det der med at kunne udskyde sine egne behov, det var fantastisk at se”*. B: *“Det er jo generelt en gruppe med meget lavt selvværd – de skal lige overvindes. Altså hun formåede jo ting, som hun ikke selv var klar over nede i vandet. Dem ville hun jo have påstået en halv time forinden, at hun ikke kunne”* (interview af professionelle).

De frivillige har fungeret som positive rollemodeller, når de har badet sammen med børn og mødre. I kombination med deres vedholdende fokus på børnene, har deres deltagelse her været med til at øge mødrenes viden om alternativer og deres mod til at bryde egne grænser: *“Vi stirrer ikke, vi kommenterer aldrig deres kroppe. Der er fokus på børnene. Når de ser os og spejler sig i andre, så kan de også (vise sig nogen). Kvindekroppe er meget forskellige, og det tror jeg ikke rigtig, at de har tænkt på før”* (interview af frivillige).

Jf. mødrene har den glæde og samhørighed, de oplevede ved at være i vandet med barnet, og den glæde de følte ved at se barnet udvikle sig, været det hele værd. Handleerfaringer, som har givet mod på mere og dermed føjet til sundhedshandlekompetence: *“Det har givet mig mod på at prøve noget andet også, fx gymnastik”* (interview af projektdeltager).

At aktiviteten har været succesfuld, men krævet overvindelse, gør den jf. Bandura særlig egnet i opbygningen af self-efficacy, ligesom begge spor i opbygning af mestring er i spil, når moderen får lejlighed til både at opleve samhørighed, udøve næstekærlighed og opleve at kunne klare at gøre noget særligt. En betydningsfuld forudsætning for mødrenes succes har været oplevelse af respektfuld og tilpas støtte både i omklædning og i vandet. Når barnet har vist tegn på ubehag har der været relationskompetente voksne, som har kunnet foregribe, at moderen blev stresset. Det har både handlet om at sætte rettidigt ind med praktisk hjælp eller råd, hjælp til at aflæse bar-

net og hjælp til at tilpasse aktivitet, så barnet blev tilpas udfordret.

En særlig ramme for opbygning af kvalitet i tilknytning

Et stressdæmpende miljø er betydningsfuldt i opbygning af self-efficacy (Bandura, A. 1990), og babysvømning tilbyder særlige muligheder for oplevelse af “stjernestunder”. Mor og barn er hud mod hud og omsluttet af behageligt tempereret vand, som giver konstante taktile input gennem det største sanseorgan – huden. Dette, sammen med den dybere respiration, som det konstante tryk på lungerne skaber, har en stressdæmpende virkning (Stern, D. 2012; Tollefsen and Borup 2002; Gjesing, Najbjerg Christensen, and Hostrup 2005). Andre faktorer som risiko for afkøling, høje lyde og anderledes lugte kan skabe mere stress, men jf. alle informanter repræsenterer babysvømning noget positivt.

Under babysvømningen står moderen i lodret position og holder sit barn ud i strakte arme i øjenhøjde. Den tætte ansigt-til-ansigt-kontakt giver gode betingelser for, under vejledning, at øve sig i at aflæse barnet og regulere dets følelser gennem mimik, øjenkontakt og stemmeføring. Også for mødre, som naturligt mestrer affektiv afstemning, giver vand en særlig mulighed for opbygning af positive arbejdsmodeller for samspil, idet der i vand ikke er plads til mobiltelefoner, cigaretter eller andet, der kan forstyrre det intense nærvær: *“Man kan bare være der og være fokuseret på det man laver. Jeg synes bare, at den kontakt man har i vandet, den gør et eller andet”* (interview af projektdeltager).

Ved at tage billeder af mor og barn hver gang og sende dem på sms, dokumenterer og tingsliggør instruktøren "stjernestunder". Dermed forstærkes muligheden for, at de bliver en del af både mor og barns identitetsfortælling: *"Det kan godt være, at der er mange andre ting, der ikke fungerer så godt, men at de andre har haft den der kontakt, det ligger derinde (...)"* *"Babysvømning handler ikke om konflikt og skældud, men er noget, hvor de kan noget sammen, hvor de nyder det sammen. Her skaber man et rum, hvor de mærker den følelse."* (interview af de professionelle).

Et rum som muliggør positive erfaringer af egen krop i bevægelse

Mens andre typer af tiltag for sårbare gravide også har haft held til at fremme mental sundhed (Sundhedsstyrelsen 2017a), så kan babysvømning bidrage med noget særligt i relation til oplevelsen af fysisk velvære. Eksisterende viden (Backhausen et al. 2014) bekræftes, idet kvinderne beskriver, hvordan de har følt sig trygge i vand og oplevet ikke bare fysisk velvære, men også bedre humør og søvn som følge af motion i vand.

Men det er ikke kun de kvinder, som har deltaget som gravide, som taler om positiv oplevelse af egen krop i bevægelse. Også i relation til at kunne bevæge sig sammen med sit barn kan vand noget særligt. Fordi tyngdekraften er delvist ophævet, udgør dårlige knæ, arme og ryg samt overvægt knap så stor en forhindring, som når man skal lege med sit barn på gulvet: *"I vand kan jeg holde til det, jeg kan hol-*

de min dreng." (interview af projekt-deltager).

Den positive oplevelse af egen mestring af bevægelse har givet mødrene det mentale overskud til at få de erfaringer, som har givet indsigt i betydningen af at udfordre barnet i positivt samvær. Flere af mødrene beskriver, hvordan de ikke selv har minder om at have lavet noget sjovt med deres forældre i relation til bevægelse, og hvordan det at fortage sig noget med barnet i en for dem ny og positiv kontekst har givet mod på mere. Også dét at måle sig op i mod og lade sig inspirere af de andre i bevægelse med deres barn er med til at opbygge handlekompetence.

En alternativ mødregruppe

Det er med projekt Aqua Vitae lykkes at skabe gode betingelser for socialt samvær mødrene imellem – en alternativ mødregruppe. Det fælles tredje – babysvømningen – har muliggjort, at et meningsfuldt socialt fællesskab har kunnet opstå. De frivillige anrettede lidt sundt at spise og drikke i forlængelse af babysvømningen, hvor børn og voksne kunne hygge sig. De fælles oplevelser og det vedholdende fokus på børnene betød, at mødrene gradvist begyndte at føle sig som en del af et fællesskab, de kunne identificere sig med og finde støtte i. Et fællesskab, hvor deres livserfaringer vandt genklang og kunne bruges af andre: *"Vi finder ud af, at vi har en hel masse tilfælles. At man ved, at de andre også har et eller andet, de bøvler lidt med, så bliver det bare vendt og drejet, der kommer nogle andre vinkler på. Det bliver alt fra baby-trivsel, til kærester til ekskærester, til ekskærester, der er far til ens børn*

(...) *de er mere modne, dem som kommer til babysvømning. Min egen mødregruppe, det var ikke rigtig noget.*" (interview af projektdeltagere).

Med baggrund i Sommerschildts model kan man sige, at mødrene har fået en oplevelse af at kunne være noget for nogen og dermed også fået modet til at åbne sig og modtage og yde næstekærlighed (Gjærum, Grøholt, and Sommerschild 2007). Dette fællesskab har bidraget til mødrenes sociale sundhed.

En anledning til at opbygge praktiske kompetencer af betydning for at mestre rollen som mor

Babysvømning tilbyder en meningsfuld kontekst til opøvelse af betydningsfulde praktiske kompetencer i rollen som mor. At skulle ud af døren med en baby og klare sig i et omklædningsrum og i en svømmehal kan selv for mødre med mange ressourcer være en udfordring. Det kræver ikke bare motivation, men også en masse praktiske kundskaber som eksempelvis at kunne planlægge og handle med overblik i en proces.

"Nu har jeg ligesom prøvet det værste – at klare mig i en svømmehal, så kan jeg også klare mig til mor-barn-gymnastik eller noget andet." (interview af projektdeltager).

Stort set alle mødrene har haft behov for hjælpende hænder i begyndelsen. En anerkendende tilgang i arbejdet med denne målgruppe er betydningsfuld (Sundhedsstyrelsen 2017a), og mødrene har enstemmigt oplevet, at den støtte, der blev stillet til rådighed for dem af de frivillige og professionelle var respektfuld og meget opbyggelig i relation til udvikling af deres egne praktiske kompetencer og selvstændig-

hed: *"Det har gjort mig mere gearret til at klare mig selv. Det gør, at jeg ved, jeg godt kan alt det der med at pakke en taske og komme afsted og klare det hele"* (interview af projektdeltager).

Men projektet har også skubbet på udvikling af mere mental karakter, som denne mor her sætter ord på: *"Det har betydet, at jeg kan bede om hjælp. For det kunne jeg ikke førhen. Det kan jeg nu: 'Kan du ikke lige hjælpe mig?'"* (interview af projektdeltager).

Opsamling af undersøgelsens resultater

Opbygning af mestring i rollen som mor handler om oplevelsen af at være noget for barnet og at kunne klare de opgaver, der følger med at være mor. Undersøgelsen viser, at det i samarbejde med fagligt dygtige og relationskompetente frivillige kan lykkes professionelle at tilrettelægge babysvømning på en sådan måde, at sårbare mødre oplever både *at være* og *at kunne*. De positive handleerfaringer giver indsigter og viden, som kan øge deres kompetence til fremadrettet at kunne handle sig til egen og barnets sundhed. Projektet belyser, hvordan påvirkningen af en dimension af sundhed kan få positiv betydning for andre. Når babysvømning gør det muligt at opleve "stjernestunder" og positive erfaringer med egen krop i bevægelse sammen med barnet, kan det bidrage ikke bare til oplevelsen af mestring, men også til fysisk velvære og mentalt overskud. Et overskud som kan bruges til at interagere socialt med de andre mødre og deres børn, hvilket igen bidrager til lyst til at komme ud og være aktiv med sit barn. Den efterfølgende positive oplevelse af at være en del af et me-

ningsfuldt fællesskab øger igen motivation og det mentale overskud til at gøre, hvad der skal til for også fremadrettet at kunne deltage i babysvømning og andre aktiviteter med andre mødre med fokus på barnets udvikling – en øget sundhedshandlekompetence.

Referencer

- Andersen, Linda Kahr, Mette Backhausen, Hanne Kristine Hegaard, and Mette Juhl. 2015. "Physical Exercise and Pelvic Girdle Pain in Pregnancy: A Nested Case-control Study within the Danish National Birth Cohort." *Sexual & Reproductive Healthcare* 6 (4):198–203.
- Antonovsky, Aaron. 2004. *Helbredets Mysterium. At Tåle Stress Og Forblive Rask*. Kbh.: Hans Reitzels Forlag.
- Backhausen, Mette G., Malene Katballe, Helena Hansson, Ann Tabor, Peter Damm, and Hanne K. Hegaard. 2014. "A Standardised Individual Unsupervised Water Exercise Intervention for Healthy Pregnant Women. A Qualitative Feasibility Study." *Sexual & Reproductive Healthcare* 5 (4):176–81.
- Bandura, Albert 1990. "Self-Efficacy: Toward a Unifying Theory Og Behavioral Change."
- Bandura, Albert. 1997. *Exercise of Persomnal and Collective Efficacy in Changing Societies In: Bandura A. (Ed). Self-Efficacy In-changing Societies.*
- Bowlby, John. 2008. *En sikker base: tilknytningsteoriens kliniske anvendelser*. Frederiksberg: Det lille Forlag.
- Brinkmann, Svend, and Lene Tanggaard. 2015. *Kvalitative metoder: en grundbog*. Kbh.: Hans Reitzel.
- Broberg, Lotte, Anne S. Ersbøll, Mette G. Backhausen, Peter Damm, Ann Tabor, and Hanne K Hegaard. 2015. "Compliance with National Recommendations for Exercise during Early Pregnancy in a Danish Cohort." *BMC Pregnancy and Childbirth* 15 (1).
- Brodén, Margareta. 2010. *Graviditetens muligheder: en tid hvor relationer skabes og udvikles*. Kbh.: Akademisk Forlag.
- Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, Statens Serum Institut, Danmark, and Sundhedsstyrelsen. 2014. *Ulighed i sundhed – kroniske og langvarige sygdomme*. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.
- Diderichsen, F. A. 2011. *Ulighed i Sundhed I: Lund, R. Christensen, U., Iversen. L. (2011) Medicinsk sociologi: sociale faktorerers betydning for befolkningens helbred*. Kbh.: Munksgaard Danmark.
- FORSK2015: fremtidens løfterigeforskningsområder. 2017. Styrelsen for Forskning og Uddannelse.
- Gadamer, Hans-Georg. 2007. *Sandhed og metode: grundtræk af en filosofisk hermeneutik*. Århus: Academica.
- Gjærum, Bente, Berit Grøholt, and Hilchen Sommerschild. 2007. *Mestring som mulighed: i mødet med børn, unge og deres forældre*. Kbh.: Hans Reitzel.
- Gjesing, Gudrun, Inga Najbjerg Christensen, and Lise Hostrup. 2005. *Vandaktivitet – mulighedernes ocean: leg og læring gennem specialpædagogik i vand*. Vejle: Kroghs Forlag.
- Gleerup, Jørgen. 2004. *Viden (Skabs) Teori I: Buur Hansen, Gleerup,j. (2004)Videnteorii, Professionsuddannelse Og Professionsforskning*.
- Hart, Susan. 2016. *Neuroaffektiv udviklingspsykologi. Makro- og mikroregulering 1 1*. S.l.: Hans Reitzel.
- Heckman, James, Elango, S., Garca, JL, and Hojman, A. 2015. "Early Childhood Education."
- Heckman, James m.fl. 2006. "Skill Formation and the Economics of Investing in Disadvantaged Children," no. vol. 312.
- Jensen, Bjarne Bruun. 2009. *Simovska Sundhedspædagogik og sundhedsfremme: teori, forskning og praksis*. Århus: Aarhus Universitetsforlag.
- Jensen, Torben K, and Tommy J Johnsen. 2010. *Sundhedsfremme i teori og praksis: en lære-, debat- og brugsbog på grundlag af teori og praksisbeskrivelser*. Århus: Philosophia.
- Jørgensen, Ole, and Marie Preisler. 2016. *En bedre start: Livsduelighed hos de allermindeste*. Kbh.: Egmont Fonden.
- Juhl, M., M. Madsen, A.-M. N. Andersen, P. K. Andersen, and J. Olsen. 2012. "Distribution and Predictors of Exercise Habits among Pregnant Women in the Danish National Birth Cohort: Exercise during Pregnancy." *Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports* 22 (1):128–38.

- Kvale, Steinar. 1997. *Interview: en introduktion til det kvalitative forskningsinterview*. Kbh.: Hans Reitzel.
- Region Syddanmark. 2014. "Fødeplan I Region Syddanmark."
- Schulz, Anette, Ulla Pedersen, University College Syddanmark, and Kosmos Nationalt Videncenter. 2010. *Sundhedspædagogik i børnehaven: en redskabsbog til inklusion og anerkendelse*. Haderslev; Frederikshavn; Dafolo: University College Syddanmark : Kosmos nationalt videncenter ;
- Stern, Daniel. 2012. *Spædbarnets interpersonelle verden – selvforbyggelsens centrale rolle og udviklingsrækkefølge I: Illeris, K. (2012) 49 tekster om læring*. Frederiksberg: Samfundslitteratur.
- Stern, Daniel. 2007. *Det nuværende øjeblik i psykoterapi og hverdagsliv*. Kbh.: Hans Reitzel.
- Stern, Daniel. 2012. *Spædbarnets interpersonelle verden: et psykoanalytisk og udviklingspsykologisk perspektiv*. Kbh.: Hans Reitzel.
- Sundhedsstyrelsen. 2016. "Motorik, Fysisk Aktivitet Og Stillesiddende Tid Hos 0-6-Årige." København.
- Stern, Daniel. 2017a. *Evaluerings af "Styrket indsats i svangreomsorgen for udsatte gravide": slutevaluering*. Sundhedsstyrelsen.
- Stern, Daniel. 2017b. "Sunde Vaner Før, under Og Efter Graviditet."
- Tollefsen, Eirik, and Hanne Borup. 2002. *Berøring & dens betydning: massage som pædagogisk redskab*. Århus: Systime.
- Zahavi, D. 2014. *Fænomenologi I: Colling og Køppe (2014) Humanistisk videnskabsteori*. 3. udg. København: Linghardt og Ringhof.